

CARTILHA AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE

PÉ TORTO CONGÊNITO



ÍNDICE

<i>O que é o pé torto congênito? _____</i>	4
<i>O Método Ponseti _____</i>	5
<i>Materiais necessários para aplicação do gesso _____</i>	6
<i>Aplicação do Gesso _____</i>	7
<i>Técnica de aplicação do gesso _____</i>	8
<i>Monitoramento após aplicação _____</i>	9
<i>Técnica segura para remoção de gesso em lactentes e crianças _____</i>	10
<i>Pontos críticos de atenção e orientações essenciais _____</i>	11
<i>Tenotomia do tendão de aquiles _____</i>	12
<i>Órtese de Dennis Browne _____</i>	13
<i>Cronograma de uso da órtese _____</i>	14
<i>Ajuste correto da órtese _____</i>	15
<i>Problemas comuns e soluções _____</i>	16
<i>Monitoramento do uso da órtese _____</i>	17
<i>Orientações essenciais para os pais _____</i>	18
<i>Cuidados e manutenção _____</i>	19
<i>Reconhecendo a recidiva _____</i>	20
<i>Questões frequentes dos profissionais _____</i>	21
<i>Resultados e prognóstico _____</i>	22
<i>Conclusão e compromisso _____</i>	23

O QUE É O

PÉ TORTO CONGÊNITO

O pé torto congênito (PTC) é uma malformação no pé e tornozelo que pode afetar um ou ambos os pés.

Esta condição comum apresenta características específicas que requerem tratamento especializado desde o nascimento.



Cavo

A curvatura do pé é mais acentuada



Adução do antepé

A parte frontal do pé está virada para dentro



Varo

O calcanhar está virado para dentro



Equino

A ponta do pé está voltada para baixo

O Método Ponseti



O objetivo é obter um pé funcional, flexível e indolor. A correção ideal é alcançada quando o tratamento é iniciado nas primeiras semanas de vida.

Desenvolvido pelo Dr. Ignacio Ponseti na década de 1950, este método é a abordagem padrão-ouro para o tratamento do PTC mundialmente. Baseia-se em princípios biomecânicos para correção gradual e indolor da deformidade.

1

Fase de gessos

Série de gessos semanais para correção progressiva das deformidades

2

Fase da tenotomia de Aquilles

Deve ser realizada na maioria das vezes para correção do equino

3

Fase de manutenção

Uso de órtese para evitar a recidiva e manter a correção alcançada

Materiais necessários para aplicação do gesso

A preparação adequada do ambiente e materiais é fundamental para o sucesso do procedimento. A pele do bebê deve estar limpa e seca, e a aplicação deve ocorrer em ambiente tranquilo.



01. Atadura de gesso

Atadura de gesso de 7,5 cm e atadura de algodão para proteção.



02. Equipamentos de proteção

Luvas, balde de água e tecido macio ou feltro/ algodão ortopédico para aplicação segura.



03. Instrumentos de corte

Tesoura de ponta romba e serra elétrica para retirada do gesso.

Aplicação do gesso

A correção deve ser progressiva e gradual, nunca forçada. O posicionamento correto do bebê e a técnica adequada são essenciais para o sucesso do tratamento.

MÉTODO PONSETI

Técnica de aplicação de gesso



Clique na imagem acima ou aponte a câmera para o QR Code para ver o vídeo sobre a aplicação de gesso.

Posicionamento do bebê

O bebê deve ficar deitado de costas com o joelho levemente flexionado. Esta posição permite melhor acesso ao pé e maior conforto durante o procedimento.

Proteção das proeminências

Proteja as proeminências ósseas com algodão: maléolos, dorso do pé, calcanhar e joelho. Esta proteção previne lesões na pele.

Técnica de aplicação do gesso



01. Manobra de correção

O profissional deve apoiar o pé do bebê com a mão, corrigindo gradualmente o cavo, a adução e o varo com o fulcro na região lateral da cabeça do tálus.

02. Início da aplicação

Começar na ponta dos dedos, deixando-os visíveis para monitoramento da circulação.

03. Extensão do gesso

O gesso vai do pé à virilha, mantendo o joelho flexionado a 90 graus.

04. Moldagem

A cada nova camada, moldar o gesso com as mãos, corrigindo as deformidades.

Monitoramento após aplicação

O monitoramento adequado após a aplicação do gesso é crucial para prevenir complicações e garantir a eficácia do tratamento.



Avaliação imediata

Verificar a circulação sanguínea nos dedos dos pés observando temperatura e coloração. Confirmar que o gesso não está causando compressão excessiva.

Orientações aos pais

Instruir sobre monitoramento domiciliar dos dedos e quando procurar atendimento médico urgente.



Sinais de Alerta: Dedos azulados, frios, inchados ou com dor intensa requerem avaliação médica imediata.

Técnica segura para remoção de gesso em lactentes e crianças

A remoção de gesso em lactentes e crianças requer técnica especializada, ambiente adequado e extrema cautela.

Este procedimento, quando realizado corretamente, garante a segurança do paciente e mantém a eficácia do tratamento ortopédico.

1 Preparação do ambiente

Local iluminado, calmo e com a criança posicionada de forma segura no colo dos pais ou em maca apropriada. Materiais preparados incluem tesoura de ponta romba, serra oscilatória (se disponível), abridor de gesso e tesoura específica. Molhar o gesso com água e vinagre facilita a retirada do gesso, amolecendo-o mais rapidamente.

4 Abertura cuidadosa

Após cortes longitudinais, utilizar abridor de gesso para afastar bordas gradualmente. Remover com cuidado mantendo a perna estabilizada durante todo o processo.

2 Seleção do método

Preferir sempre remoção manual com tesoura de ponta romba e abridor de gesso para reduzir riscos de lesões cutâneas. Serra de gesso deve ser usada com extrema cautela devido ao risco de queimaduras por fricção.

3 Técnica de corte

Realizar dois cortes longitudinais (medial e lateral) desde a borda proximal até distal, evitando regiões ósseas proeminentes como malleoli, calcâneo e dorso do pé. Inserir tesoura entre gesso e pele.

5 Cuidados após remoção

Limpar suavemente a pele com gaze ou pano úmido sem esfregar. Observar áreas de hiperemia, bolhas ou escoriações. Orientar hidratação com creme neutro se necessário.



Cuidados e orientações

Cuidados específicos no lactente

- Evitar movimentos bruscos que possam assustar o bebê.
- Nunca usar objetos cortantes diretamente sobre a pele delicada.
- Atenção especial a áreas de dobra: joelho, tornozelo e dedos.
- Inspecionar correção obtida antes do novo gesso.

Orientações complementares

- Procedimento deve ser realizado apenas por profissional treinado.
- Envolver os pais explicando cada etapa para reduzir ansiedade.
- Intervalo entre gessos deve ser curto para não perder correção.
- Manter ambiente calmo e acolhedor durante todo processo.

Lembre-se: A segurança do lactente é prioridade absoluta. Em caso de dúvida sobre qualquer aspecto da técnica, interrompa o procedimento e consulte um colega mais experiente. O bem-estar da criança e a tranquilidade da família dependem da nossa competência técnica e cuidado humano.

Tenotomia do tendão de aquiles

Após a série de gessos, o tendão de Aquiles pode permanecer encurtado, impedindo a correção total do pé. A tenotomia é um procedimento simples e eficaz para resolver esta limitação.

02. Procedimento

Pequena incisão de 2 a 3 mm no tendão de Aquiles, realizada sob anestesia local. É um procedimento ambulatorial de baixo risco.



01. Indicação

Realizada quando o tendão de Aquiles permanece tenso após a correção das outras deformidades com gessos seriados.

03. Pós-Cirurgia

Um último gesso é aplicado por três semanas para permitir a cicatrização completa do tendão em posição alongada.



Órtese de Dennis Browne

A órtese de Dennis Browne é fundamental para manter a correção alcançada com os gessos e prevenir a recidiva da deformidade. *Consiste em dois sapatos conectados por uma barra metálica ajustável.*

Componentes

Dois sapatos abertos na ponta conectados por barra metálica com ângulo e comprimento ajustáveis
Apresenta orifício na região do calcâneo para verificar o posicionamento adequado.

Objetivo

Impedir a recidiva do pé torto congênito mantendo a correção obtida.

Ajustes

Ângulo de rotação e comprimento da barra personalizáveis para cada paciente.

MÉTODO PONSETI

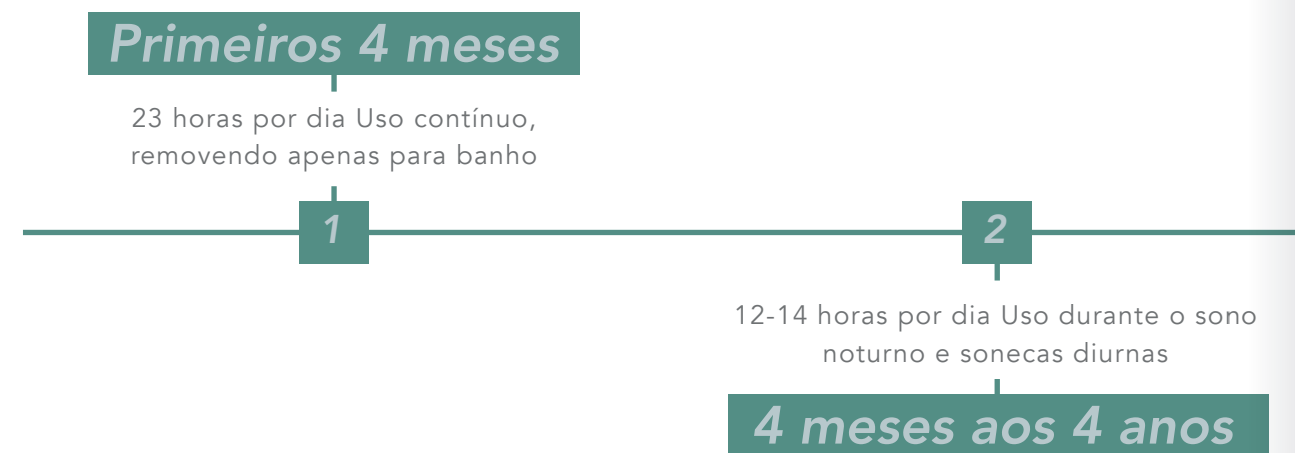
Órtese de Dennis Browne



Clique na imagem acima ou aponte a câmera para o QR Code para ver o vídeo de orientação sobre a colocação da órtese de Dennis Browne.

Cronograma de uso da órtese

O sucesso do tratamento depende fundamentalmente da adesão rigorosa ao cronograma de uso da órtese. A falta de adesão é a principal causa de recidiva da deformidade.



“A adesão ao protocolo de uso da órtese é o fator mais crítico para o sucesso a longo prazo do tratamento.”

Ajuste correto da órtese

O ajuste preciso da órtese é essencial para sua eficácia. Parâmetros incorretos podem comprometer o resultado do tratamento ou causar desconforto desnecessário.

60-70°

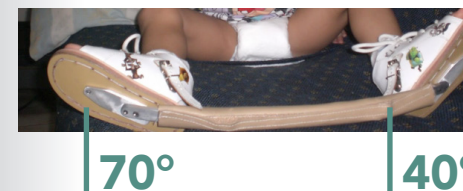
Pé afetado

Graus de rotação externa para o pé com deformidade

30-40°

Pé saudável

Graus de rotação externa para o pé normal (casos unilaterais)



O comprimento da barra deve ser igual à distância entre os ombros do bebê. Este parâmetro deve ser reavaliado regularmente conforme o crescimento da criança.



Problemas comuns e soluções

Durante o uso da órtese, alguns problemas podem surgir.

O reconhecimento precoce e a correção adequada são fundamentais para manter a adesão ao tratamento.

- 1** **Pés inchados ou vermelhos**
Causa: Sapato muito apertado.
Solução: Verificar e ajustar o aperto das alças do sapato.
- 2** **Bebê chorando persistentemente**
Causa: Desconforto ou posicionamento incorreto.
Solução: Verificar posição do pé na órtese.
- 3** **Calcanhar escorregando**
Causa: Alça frouxa ou tamanho inadequado.
Solução: Ajustar aperto ou trocar tamanho.
- 4** **Assaduras**
Causa: Umidade na pele.
Solução: Manter pele seca antes de colocar o sapato.

Monitoramento do uso da órtese até os 4 anos

O acompanhamento regular é essencial para garantir o crescimento adequado e prevenir complicações. O cronograma de consultas deve ser rigorosamente seguido.

- 0-4 Meses**
Consultas mensais para ajustes e monitoramento da adesão ao uso 23h/dia
- 4 Meses - 2 Anos**
Consultas a cada 3 meses para ajustes conforme crescimento
- 2-4 Anos**
Consultas semestrais para monitoramento e ajustes finais

A cada consulta, verificar o comprimento da barra, tamanho do sapato e ângulos de rotação, ajustando conforme o crescimento da criança.



A criança deve manter **acompanhamento regular** até o término do crescimento osseo do pé.

Orientações essenciais para os pais

O sucesso do tratamento depende fundamentalmente do envolvimento e compreensão dos pais. A educação adequada é crucial para garantir a adesão ao protocolo.

Educação contínua

Enfatizar constantemente a importância do uso contínuo da órtese. Explicar as consequências da não adesão de forma clara e compreensível.

Integração na rotina

Ajudar os pais a integrar o uso da órtese na rotina diária, estabelecendo horários fixos para colocação e retirada.



Cuidados e manutenção

A manutenção adequada da órtese garante sua durabilidade e eficácia. Cuidados simples podem prevenir problemas e aumentar o conforto da criança.

Limpeza regular

O sapato e a barra podem ser limpos com pano úmido. Evitar submersão em água ou uso de produtos químicos agressivos.

Estímulo à atividade

A criança pode engatinhar e brincar com a órtese. Estas atividades estimulam o desenvolvimento da força muscular e mobilidade.

Reconhecendo a recidiva

A recidiva é o retorno da deformidade, geralmente causado pelo uso inadequado da órtese. O reconhecimento precoce permite intervenção rápida e eficaz.

MÉTODO PONSETI

Reconhecimento de Recidiva



Clique na imagem acima ou aponte a câmera para o QR Code para ver o vídeo sobre o reconhecimento da recidiva.

Sinais de alerta

Calcanhar voltando a se virar para dentro e retorno da adução do antepé são os principais indicadores de recidiva.

Ação imediata

Buscar o especialista em ortopedia imediatamente para avaliação e possível reinício do ciclo de gessos.

“A detecção precoce da recidiva permite tratamento mais simples e eficaz, evitando procedimentos mais complexos.”

Questões frequentes dos profissionais

Respostas às dúvidas mais comuns dos profissionais de saúde sobre o tratamento do pé torto congênito pelo Método Ponseti.

“Qual a idade ideal para começar?”

O mais cedo possível, idealmente nas primeiras semanas de vida. O tratamento precoce oferece melhores resultados.

“E se o bebê chorar muito no gesso?”

Verificar se o gesso não está muito apertado. Desconforto inicial é comum, mas dor intensa não é normal.

“Como garantir adesão dos pais?”

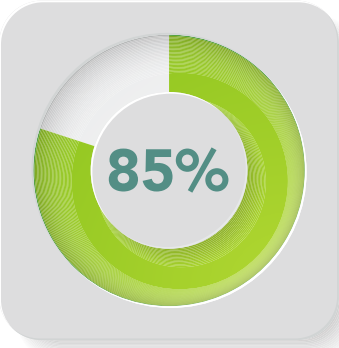
Educação contínua, explicações claras sobre consequências e apoio emocional são fundamentais.

Resultados e prognóstico

O Método Ponseti apresenta excelentes resultados quando aplicado corretamente. A taxa de sucesso é superior a 95% quando há adesão adequada ao protocolo.



Taxa de sucesso
Com adesão adequada ao protocolo completo de tratamento.



Satisfação dos pais
Relatam alta satisfação com os resultados funcionais.



Taxa de recidiva
Principalmente relacionada à não adesão ao uso da órtese.

Conclusão e compromisso

O Método Ponseti representa uma revolução no tratamento do pé torto congênito, oferecendo resultados excepcionais com abordagem minimamente invasiva. O sucesso depende da aplicação correta da técnica e, principalmente, da adesão rigorosa ao protocolo de uso das órteses.



“A adesão dos pais e a orientação precisa dos profissionais de saúde são a chave para transformar vidas através do Método Ponseti.”

Referências bibliográficas

- ALMEIDA, D. M. Elaboração de materiais educativos. 2017. Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4412041/mod_resource/content/1/ELABORA%C3%87%C3%83O%20MATERIAL%20EDUCATIVO.pdf. Acesso em: 13 ago. 2025.
- ANDRADE, M. et al. Desenvolvimento de uma cartilha educativa sobre a saúde dos pés. **Revista Escola de Saúde Paraná**, v. 7, n. 1, p. e894, 2024. DOI: <https://doi.org/10.32811/25954482-2024v7n1894>.
- ARAÚJO, E. F. et al. Elaboração de tecnologia educacional sobre educação em saúde para crianças com diabetes mellitus tipo I. **Revista Enfermagem em Foco**, v. 11, n. 6, p. 185-191, 2020.
- ARKIN, C.; IHNOW, S.; DIAS, L.; SWAROOP, V. T. Midterm Results of the Ponseti method for treatment of clubfoot in patients with spina bifida. **J Pediatr Orthop**, v. 38, n. 10, p. e588-e592, 2018.
- BARRIE, M. V. A. **Clubfoot**. StatPearls, 2022.
- BRASIL. Fundação Nacional de Saúde. **Diretrizes de educação em saúde visando à promoção da saúde**: documento base - documento I. Brasília: Funasa, 2007.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento de Ciência e Tecnologia. **Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde**. 2. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2015. (Série B. Textos Básicos de Saúde).
- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais. **Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Atenção Integral às Pessoas com Infecções Sexualmente Transmissíveis**. Brasília: Ministério da Saúde, 2015.
- CADY, R.; HENNESSEY, T. A.; SCHWEND, R. M. Diagnosis and Treatment of Idiopathic Congenital Clubfoot. **Pediatrics**, v. 149, n. 2, p. e2021055555, 2022.
- CAPES. Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior. **Produção técnica**: grupo de trabalho. 2020. Disponível em: <http://www.capes.gov.br/pt/relatorio-tecnicos-day>. Acesso em: 16 ago. 2025.
- CARPES, A. D.; ZAMBERLAN, C.; COSTENARO, R. G. S. Pesquisa-Ação em saúde associada a outros dispositivos e ferramentas. In: LACERDA, M. R.; COSTENARO, R. G. S. **Metodologias da Pesquisa para a enfermagem e Saúde**: da teoria à prática. Porto Alegre: Moria, 2015.
- CHUEIRE, A. J. F. G. et al. Treatment of congenital clubfoot using Ponseti method. **Revista Brasileira de Ortopedia**, v. 51, n. 3, p. 313-318, 2016.
- CORDEIRO, F. G. et al. Congenital Clubfoot – Is the Ponseti Method the Definitive Solution? **Rev Bras Ortop**, v. 56, n. 6, p. 683-688, 2021.
- CUNHA, R. M. et al. Qualidade de vida de crianças com pé torto congênito e a técnica de Ponseti. **Revista Brasileira de Qualidade de Vida**, v. 11, n. 1, 2019. Disponível em: <https://periodicos.ufpr.edu.br/tbqv/article/view/8440>. Acesso em: [data de acesso].
- DIAS, H. F. R. et al. Síndrome do pé torto congênito: uma revisão sistemática. **Brazilian Journal of Development**, v. 8, n. 5, p. 37823-37, 2022. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/48106>. Acesso em: [data de acesso].
- FORTIS-OLMEDO, I. O. et al. Adherence to the Ponseti method by family members as a determinant in the success of club foot treatment. **Acta Ortop Mex**, v. 34, n. 1, p. 43-46, 2020.
- GANESAN, B. et al. Ponseti method in the management of clubfoot under 2 years of age: a systematic review. **PloS One**, San Francisco, v. 12, n. 6, e0178299, 2017.
- GARCIA, L. C. et al. Evaluation of Kite and Ponseti Methods in the Treatment of Idiopathic Congenital Clubfoot. **Acta Ortop Bras**, v. 26, n. 6, p. 366-369, 2018.
- GAYTÁN-FERNÁNDEZ, S. et al. Four years follow up in congenital talipes equino varus patients managed with Ponseti method. **Acta Ortop Mex**, v. 35, n. 2, p. 197-200, 2021.
- GUERSCHEMAN, T. M.; NOGUEIRA, M. P. Curva de aprendizado no método Ponseti evolução em intervalos de 5 anos. **Acta Ortop Bras**, v. 32, n. 1, p. e273739, 2024.
- HAFT, G. F.; WALKER, C. O.; CRAWFORD, H. A. Recorrência precoce do pé torto após o uso do método Ponseti. **J Bone Joint Surg Am**, v. 89, n. 3, p. 487-493, 2007.
- HECK, L. O.; CARRARA, B. S.; VENTURA, C. A. A. Nursing and health advocacy: development process of an educational manual. **Texto & Contexto – Enfermagem**, v. 31, p. e20210364, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1590/1980-265X-TCE-2021-0364en>.
- HERZENBERG, J. E.; RADLER, C.; BORN, N. Ponseti versus traditional methods of casting for idiopathic clubfoot. **J Pediatr Orthop**, v. 22, n. 4, p. 517-521, 2002.
- HOPWOOD, S. et al. Clubfoot: an overview and the latest UK guidelines. **Br J Hosp Med**, v. 84, n. 1, p. 1-7, 2023.
- JAQUETO, P. A. et al. Functional and clinical results achieved in congenital clubfoot patients treated by Ponseti's technique. **Rev Bras Ortop**, v. 51, n. 6, p. 657-661, 2016.
- KOERICH, M. S. et al. Pesquisa-ação: ferramenta metodológica para a pesquisa qualitativa. **Rev Eletr Enferm**, Goiânia, v. 11, n. 3, jun. 2017. Disponível em: <https://www.revistas.ufg.br/en/article/view/47234/23150>. Acesso em: 16 ago. 2025.
- LARA, L. C. R. et al. Treatment of idiopathic congenital clubfoot using the Ponseti method: ten years of experience. **Rev Bras Ortop**, v. 48, n. 4, p. 362-367, 2013.
- LIMA, A.; SANTOS, S. **O material didático na EaD**: princípios e processos. Módulo IV, 2019.
- LIMA, N. D. et al. Educação em saúde e na saúde: conceitos, pressupostos e abordagens teóricas. **SANARE - Revista de Políticas Públicas**, [S. l.], v. 21, n. 2, 2022. DOI: <https://doi.org/10.36925/sanare.v2i2.1669>. Disponível em: <https://sanare.emnuvens.com.br/sanare/article/view/1669/842>. Acesso em: [data de acesso].
- MIEDZYBRODZKA, Z. Congenital talipes equinovarus (clubfoot): a disorder of the foot but not the hand. **J Anat**, v. 202, n. 1, p. 37-42, 2003. DOI: 10.1046/j.1469-7580.2003.00147.x.
- MINAYO, M. C.; DESLANDES, S. F.; GOMES, R. **Pesquisa Teoria Social, Método e Criatividade**. Editora Vozes, 2016.
- MOSCA, V. S. **Clubfoot**: Biomechanics and practical principles-based application of the Ponseti method. Seattle, WA: Global HELP Organization, 2021. Disponível em: https://global-help.org/products/clubfoot_biomechanics/. Acesso em: [data de acesso].
- OLIVEIRA, C. L. T.; GONÇALVES FILHO, G. M.; VOLPON, J. B. Avaliação do tratamento precoce do pé torto congênito idiopático pelo método de Ponseti. **Acta Ortopédica Brasileira**, São Paulo, v. 31, n. 2, e259899, 2023.
- ONU – ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. **Transformando nosso mundo**: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Brasília: ONU, 2015. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>. Acesso em: 17 ago. 2025.
- PAULSEN-MILLER, M.; DOLAN, L. A.; STINEMAN, A.; MORCUENDE, J. A. Understanding the educational needs for parents of children with clubfoot. **Orthop Nurs**, v. 30, n. 4, p. 273-278, 2011.
- PAYONE, V. et al. The etiology of congenital talipes equinovarus: a systematic review. **Journal of orthopaedic surgery and research**, v. 13, n. 1, p. 206, 2018.
- PONSETI, I. V.; SMOLEY, E. N. The classic: congenital club foot: the results of treatment. 1963. **Clin Orthop Relat Res**, v. 467, n. 5, p. 1133-1145, 2009.

Espaço para informações

Telefone

Email